Was wann: Techniken und Beachten je Schritt

Die Schritte sind Bausteine, kein starres Programm. Reihenfolge und Dichte richten sich nach der Person.

Beratung, nicht Psychotherapie

1 Ankommen

Ziel: Vertrauen, Risiko und Anliegen sind geklärt.

TECHNIKEN

- Auftrag und Anliegen klären
- Motivierende Gesprächsführung: offene Fragen, Ambivalenz aufgreifen
- Verhaltensanamnese: was, wie oft, wie lange, mit welchen Folgen
- Kurze Psychoedukation
- Erstziel skizzieren

BEACHTEN

- Suizidalität und Krise direkt erfragen
- Vertraulichkeit und Schweigepflicht früh erklären
- Scham: Sprache ohne Moral, „Sucht" nur, wenn die Person es sagt
- Dem Tempo der Person folgen

2 Verstehen

Ziel: Funktion, Auslöser und Folgen des Verhaltens sind klar.

TECHNIKEN

- Selbstbeobachtungsprotokoll: Häufigkeit, Gedanken, Gefühle, Auslöser, Folgen
- Funktionale Verhaltensanalyse
- Kosten-Nutzen-Analyse
- Optional: Screener als Gesprächsanker (BSAS, PBS, CSBD-19, PPCS-6)

BEACHTEN

- Komorbidität erfragen und zuweisen, nicht diagnostizieren
- Bagatellisieren und Verheimlichen sind kein Widerstand, sondern Teil des Bildes
- Selbstbericht ist verzerrbar, Screener sind keine Diagnose

3 Ziele setzen

Ziel: gemeinsame, messbare Ziele auf drei Ebenen.

TECHNIKEN

- Zieloffene Arbeit: Abstinenz oder Kontrolle
- Staffelung: Rahmen-, Teil-, Handlungsziel
- SMART formulieren
- Goal Attainment Scaling, Skala –2 bis +2
- Imaginationsübung: Zukunft mit und ohne Verhalten

BEACHTEN

- Ziele setzt die Person, Zahlen nicht vorgeben
- Realistisch und erreichbar, das stützt die Motivation
- Abstinenzausmass je Verhalten: z. B. Kaufen nicht ganz meidbar, Ziel bedarfsgerecht

4 Verändern

Ziel: Kontrolle zurückgewinnen, Alternativen aufbauen.

TECHNIKEN

- Stimuluskontrolle und Reaktionsverzögerung
- Verhaltensaktivierung, Wochenstruktur
- Craving-Skills, Selbstsperren, Limiten
- Geld- und Schuldenmanagement, Schuldenberatung
- Einfache Strategien für Emotionsregulation und Stress
- Angehörige einbeziehen, mit Einwilligung

BEACHTEN

- Grenzbereich: Exposition mit Reaktionsverhinderung und systematische kognitive Umstrukturierung eher Psychotherapie
- Abbrüche und Rückfälle sind zu erwarten
- Angehörige nicht konfrontativ coachen

5 Festigen

Ziel: Erreichtes sichern, Weiterführung klären.

TECHNIKEN

- Rückfallprophylaxe: Frühwarnzeichen, Plan für Ausrutscher
- Zielerreichung auswerten (Skala –2 bis +2)
- Soziales Netz und reale Kontakte stärken
- Rückmeldung an Hausarzt, mit Einwilligung
- Katamnese nach etwa drei Monaten

BEACHTEN

- Triage prüfen: Ziele trotz Mitarbeit nicht erreicht, Komorbidität im Vordergrund oder Wunsch nach Tiefenarbeit
- Weiterverweisung gemeinsam besprechen, Kostenfrage klären